

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 12	Bezeichnung des Dokumentes: Verbandwechsel einer aseptischen Wunde	

Durchführende:

- Pflegefachkräfte (PFK)

Pflegeziel:

- rasche und komplikationslose Wundheilung
- Infektionsvermeidung
- Schmerzlinderung

- Schnittwunden, Operationswunden
- Schmerzlinderung
- Beobachtung und Dokumentation des Wundzustandes
- nach ärztlicher Anordnung

Indikation:

- unter einer Wunde versteht man eine durch äußere Einflüsse z.B. operative Eingriffe, mechanische Einwirkung oder thermische Einflüsse entstandene Durchtrennung oder Zerstörung der Haut sowie der darunter liegenden Gewebeschichten

Kontraindikationen:

- Ablehnung durch den Patienten

Vorbereitung:

- Hände waschen und Händedesinfektion
- Patient informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen zusammenstellen
- für ausreichende Lichtverhältnisse sorgen

Material:

- Händedesinfektionsmittel
- Einmalhandschuhe
- Verbandmittel
- Abwurfbehälter

Durchführung:

- Einsichtnahme in die Maßnahmeplanung
- Händedesinfektion
- Einmalhandschuhe anziehen
- Verband abnehmen und werfen
- Wundinspektion
- Versorgung der Wunde nach ärztlicher Anordnung
- neuen Verband anlegen
- Anwendung der „10-R-Regel zur qualitätsgesicherten Medikamentengabe“

Hinweise:

- unser Pflegedienst bleibt hauptverantwortlich für die Wundversorgung auch wenn Dritte (bspw. Wundschwestern, Wundmanager oder Pflegerische Fachexpertin) einbezogen werden
- Reinigung einer aseptischen Wunde von innen nach außen
- bei der allgemeinen Betreuung und der Wundversorgung bei einem Dekubitus, einem Ulcus cruris bzw. einem Diabetischen Fußsyndrom ist nach unserem Standard „Pflege von Menschen mit chronischen Wunden“ zu verfahren

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

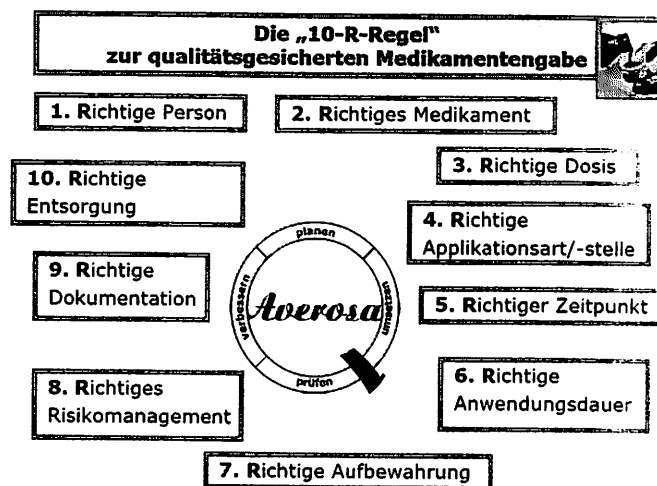
Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 12	Bezeichnung des Dokumentes: Verbandwechsel einer aseptischen Wunde	

Nacharbeiten:

- Abfall entsorgen
- Händedesinfektion
- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen Zustands, der Haut, des seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- Bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL bzw. die diensthabende PFK (PFP)

Festlegungen zur Wunddokumentation:

- Für jede Wunde ist 1 Wunddokumentationsbogen, chronische Wunden anzulegen.
- Die Dokumentation des Wundzustandes hat durch PFK in Zusammenarbeit mit der PFE bspw. nach dem Entfernen von avitalem Gewebe (Debridement), bei akuten Veränderungen, nach jedem Verbandwechsel bzw. mindestens alle 7 Tage zu erfolgen
- Zur Bewertung des Heilungsverlaufes bzw. Wundveränderungen können Fotos gefertigt werden. Der Patient hat hierzu eine Einwilligungserklärung nach § 201 a StGB zu unterzeichnen, wird das Fotografieren durch den Patienten abgelehnt, ist die Wunde zu beschreiben.
- Wundfotos sind in monatlichen Abständen anzufertigen. Soweit möglich sind folgende Dinge zu beachten: vorher die Wunde spülen, gleiche Lichtverhältnisse, gleicher Abstand zum Objekt, Wunde soll mindestens 1/3 des Fotos einnehmen, gleicher Mitarbeiter, der fotografiert, Anlegen von Messmitteln ohne die Wunde zu verdecken, der Name des Patienten und das Datum müssen erkennbar sein (Wundfotos ersetzen eine Beschreibung der Wunde nicht.).



Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA